

Un enfant autiste dans votre cabinet

Pour les médecins de famille, les infirmiers et les professionnels de santé — soigner un enfant d'âge préscolaire autiste (environ 2 à 5 ans).

L'idée centrale

L'autisme, vu sous l'angle du **monotropisme**, signifie que l'attention d'un enfant est attirée vers quelques « tunnels » profonds et intenses à la fois. À l'intérieur d'un tunnel, la focalisation est vive et riche ; à l'extérieur, les choses sont à peine perçues — y compris parfois la douleur, la faim, ou quelqu'un qui parle. Le passage d'un tunnel à un autre coûte une énergie réelle (*inertie autistique*). Cela explique les intérêts forts, les réactions sensorielles, le besoin de routine et les meltdowns/shutdowns. La chose la plus utile que vous puissiez faire en clinique est de travailler **avec** le tunnel, et non contre lui.

Ce que vous pouvez observer — et ce qui se passe réellement

Vous observez...	Ce qui se passe souvent
Refuse le contact visuel ; détourne le regard ; semble vous ignorer	Le contact visuel et l'attention divisée coûtent des ressources rares ; regarder ailleurs aide l'enfant à se réguler et à écouter
Profondément absorbé par un objet ; aligne des objets ; joue « différemment »	Jeu monotropique — valide et significatif, et non « incorrect » ; c'est souvent la voie de l'enfant vers le calme et l'apprentissage
Pleurs soudains, cris, corps qui devient mou ou silence total	Un meltdown ou un shutdown involontaire dû aux lumières, au bruit, l'attente ou la douleur — ce n'est <i>pas</i> de la malveillance
Ne dit pas où il a mal ; ne sent pas un coup ou une brûlure	Lorsqu'il est absorbé, la douleur et les signaux internes peuvent véritablement ne pas être enregistrés
Lent à répondre ; répète vos mots	Temps de traitement + communication littérale sur un canal unique

Essayez ceci

- **Lisez d'abord le profil de la famille.** Proposez un court formulaire de pré-visite (comme l'outil *Autism Healthcare Accommodations Tool* d'AASPIRE, autismandhealth.org) demandant les besoins sensoriels, de communication et de procédure — et lisez-le avant leur arrivée.
- **Réservez le créneau le plus calme** (premier ou dernier), permettez la présence d'un adulte de confiance, et accueillez leur **kit sensoriel** (casque antibruit, lunettes de soleil, un objet de confort ou d'intérêt).
- **Réduisez la charge** : tamisez les lumières, coupez les bips si possible, évitez les parfums forts.
- **Dites ce qui va se passer, puis faites-le** — phrases courtes et littérales, une étape à la fois ; montrez l'équipement d'abord.
- **Laissez l'enfant détourner le regard, stimmer et tenir son objet d'intérêt** pendant l'examen. Rejoignez son intérêt pour établir un rapport *avant* de procéder à l'examen.

Évitez ceci

- Forcer le contact visuel, immobiliser l'enfant ou imposer une procédure par surprise.
- Donner de longues instructions verbales ou utiliser des phrases comme « sois courageux ! » — dites exactement ce qui va se passer, et tenez parole.
- Interpréter quelques minutes de calme (masquage) comme un signe que « tout va bien » — un enfant d'âge préscolaire peut payer la visite par un shutdown après coup.

Quand demander plus de soutien

Orientez tôt vers une évaluation de l'autisme si vous remarquez une attention ralentie ou « collante », des intérêts focalisés intenses, des différences sensorielles ou un jeu atypique — l'identification précoce aide les familles à adapter l'environnement, pas l'enfant. Soyez attentif au **burnout autistique** / à la « **régression** » sous l'effet de la surcharge : une perte de compétences signifie généralement qu'il faut *réduire les exigences et restaurer le repos et les intérêts*, et non pousser davantage. Prenez toujours au sérieux les **préoccupations parentales**. Orientez vers la visiteuse de santé, les services pédiatriques et le soutien parental dirigé par des autistes localement.

Si l'enfant est une fille

Les filles sont souvent plus douces pour le **camouflage** précoce et sont plus souvent oubliées. Prenez les préoccupations parentales au sérieux même lorsque la présentation semble « subtile » ou « sociable » — l'effort du masque en clinique est un effort réel.

À propos de ce guide

Assisté par IA, dérivé des brouillons de recherche du projet — le brief **Monotropisme** et le **Guide pour les praticiens et professionnels de santé** (Parties 3.1 & 4). Utilisez le langage identitaire (« enfant autiste »). **Informatif — ce n'est pas un avis médical ni un outil de diagnostic.** Le monotropisme est une théorie puissante mais encore en développement ; adaptez-la toujours à l'enfant individuellement.

Sources clés. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2018/2023); Dwyer (2025); AASPIRE Healthcare Toolkit / AHAT (autismandhealth.org); Raymaker et al. (2020, burnout autistique); Kelly Mahler (2024, interoception); Landry & Bryson (2004, regard collant). Les citations complètes se trouvent dans les brouillons sources.